

統合失調症スペクトラム障害 および他の精神病性障害群

～2025年度 M4講義～

名古屋市立大学大学院 医学研究科

精神・認知・行動医学

白石 直

本日の概要

1. 疫学・病因・薬理
2. 臨床症状
3. ビデオ供覧
4. 診断・経過
5. 治療・予後

疫学

- 有病率は1%程度、罹病率はおよそ1.5人/10千人・年
- 男性：女性 = 1.4：1
- 青年期に好発し、小児期・老年期発症は稀
- 男性の発症年齢のピークは（18-25歳）、女性より若く（25-35歳）、予後より悪い
- 女性の発症年齢のセカンド・ピークは、閉経前後

1. McGrath J, et al. Epidemiologic reviews. 2008;30:67-76.
2. Abel KM, et al. International review of psychiatry. 2010;22(5):417-28.
3. Grossman LS, et al. Comprehensive psychiatry. 2008;49(6):523-9.
4. Usall J, et al. Eur Psychiatry. 2003;18(6):282-4.

病因: 遺伝素因

□ 一卵性双生児の養子研究

発病率は、生みの親が統合失調症であるかによって変わるが、育ての親がどちらであっても同率

□ 発病は、育て方（環境素因）で決まるわけではない

□ 統合失調症患者の

一卵性双生児の発症率: 40-50%

二卵性双生児の発症率: 10-15%

1. Kringlen E, Am J Med Genet. 2000;97(1):4-11.
2. Cardno AG, et al. Arch Gen Psychiatry. 1999;56(2):162-8.
3. Cannon TD, et al. Arch Gen Psychiatry. 1998;55(1):67-74.

病因: 環境素因

- 産科合併症
- 感染症
インフルエンザ、トキソプラズマ症
- 炎症反応
- 大麻使用
- 移民

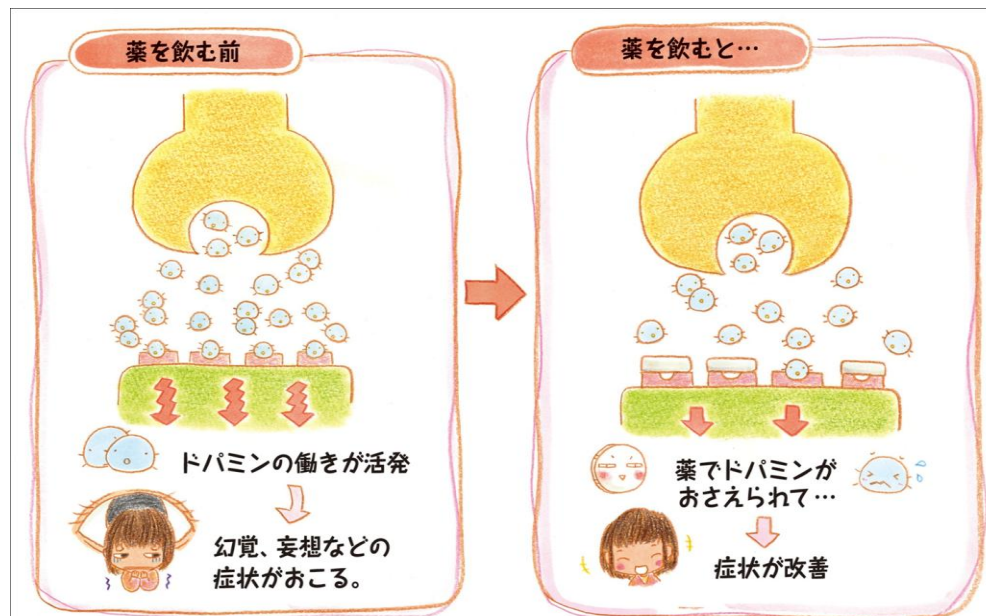
遺伝・環境素因の複雑な相互作用で発症

1. van Os J, et al. Am J Epidemiol. 2002;156(4):319-27.
2. Kuepper R, et al. Bmj. 2011;342:d738.
3. McGrath J, et al. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(5):440-7.
4. Werbeloff N, et al. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012;47(2):303-11.
5. Bourque F, et al. Psychol Med. 2011;41(5):897-910.

薬理: ドーパミン仮説

ドーパミン作動性ニューロンの過剰活動が統合失調症の発病に関与するという仮説

- ドーパミン受容体（D2）拮抗剤には、幻覚・妄想を改善する作用がある
- ドーパミン作動性ニューロンを刺激する薬物の作用で、幻覚・妄想が出現する



薬理: 他の神経伝達物質

セロトニンその他、複数の神経伝達物質が関与

□ グルタミン酸

グルタミン酸受容体の一種であるN-methyl-D-aspartate (NMDA) 受容体の機能低下

□ Gamma-amino-butyric acid (GABA)

前頭葉皮質の機能を調節するGABA作動性介在ニューロンの機能異常

□ アセチルコリン

ムスカリン性アセチルコリン受容体作動薬の xanomeline-trospiumが2024年9月に米国で承認¹

1. Schneider-Thoma J, Lancet. 2026;407(10531):876–891.

臨床症状

- 陽性症状
幻覚、妄想、解体症状
- 陰性症状
感情の平板化、意欲欠如
- 緊張病症状
- 気分症状
抑うつ、不安
- 認知機能障害

＜DSM-5*の診断基準＞
下線から**2項目を1か月**
＋前駆または残遺症状を
5か月

（満たすべき2項目中、
妄想・幻覚・解体症状の
いずれか1項目が含まれ
ることが必須）

幻聴 Hallucinations

- 現実には対象が存在しないにもかかわらず真の知覚とは区別できない知覚体験
- 分類として、幻聴・幻視・体感幻覚・幻嗅・幻味がある
- 幻聴が最多で、統合失調症患者の40-80%に出現する
- 通常、声として体験されるが、要素性幻聴（音楽や機械音等）もある

歴史上の統合失調症の症候学

＜シュナイダーの一級症状＞

- 考想化声
- 会話形式の幻聴
- 自分の行為を絶えず批判する声の幻聴
- 身体への影響体験
- 思考領域での影響体験
- 思考吹入
- 思考奪取
- 思考伝播
- 感情や衝動や意志の領域に現れる影響体験

□ 統合失調症患者に特徴的な症状とされていた

□ 縦断研究で、躁状態の双極症患者の半数弱に症状有

□ 現在、疾患特異的な症状とは見なされていない

妄想 Delusions

非科学的な現象
を信じている人々の割合

- 神 68%
- テレパシー 50%以上
- 予知・予言 50%以上
- 心霊現象 25%以上
- 迷信 25%
- 輪廻・転生 25%
- 占い 23%
- 悪魔 21%

妄想の有無を判断するには、患者の文化的背景と病前の能力を考慮することが必要

□ 宗教上の信念

□ コミュニケーションの障害（e.g. 自閉症スペクトラム症）

妄想 Delusions

- 論理的反証によってもその不合理性を訂正できない自己に関連した誤った確信
- 統合失調症患者の80%に出現する
- 分類：被害妄想、関係妄想、嫉妬妄想、身体妄想、誇大妄想、被愛妄想等
- 心理的にそれ以上さかのぼれない妄想を一次妄想（真性妄想）と呼ぶ
- 感覚・体験・妄覚から了解しうる様に発生する妄想を二次妄想（妄想様観念）と呼ぶ

幻聴に対する認知と二次妄想

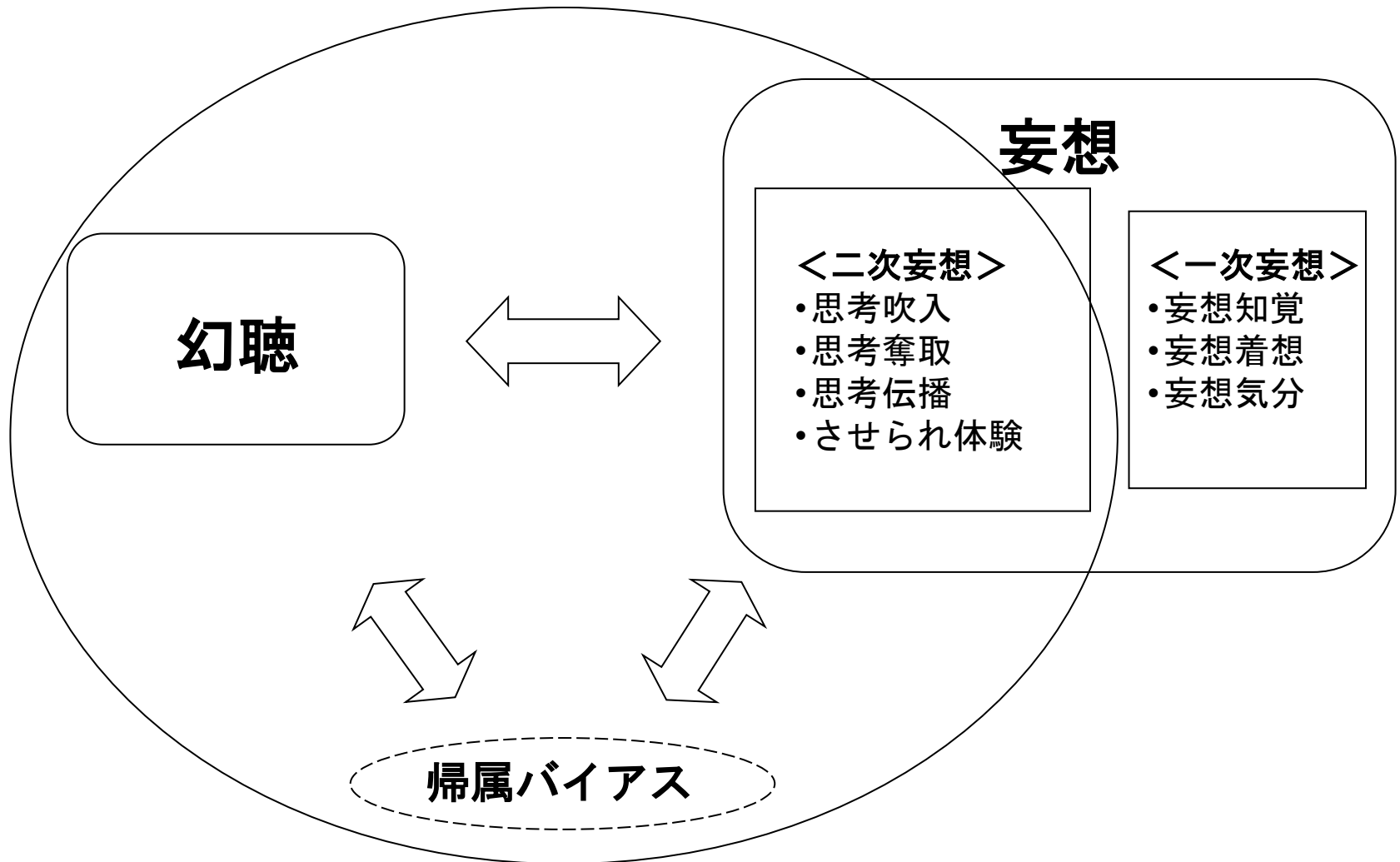
幻聴を「実際の」他人の声と認知すると、妄想に発展して精神的苦痛が悪化する



幻聴に対する認知と二次妄想

- 「個人情報流出し、自分が噂されている」
➡ 被害妄想
- 「神や霊的なものからのお告げ」と信じる
➡ 誇大妄想
- 「自分の考えが他人に筒抜けになっている」
➡ 思考伝播
- 「テレパシーや電波」と信じる
➡ させられ体験

幻聴と妄想の相互的關係



1. Baker CA et al. Psychological medicine. 1998;28(5):1199-208.
2. Shiraishi N et al. J Nerv Ment Dis. 2004; 202(1): 35-39.

帰属バイアスと病識

＜病識の3要素＞

- 幻聴や妄想が自分自身に由来していることを受け入れる
- 自分が病気であることを受け入れる
- 治療の必要性を受け入れる

幻聴の由来（発信源）の他者への帰属は、
幻聴に対する認知に影響を与える

陰性症状 Negative symptoms

- 構成因子は、感情の平板化と意欲欠如
- 感情の平板化とは、情動の表出が減少すること
- 意欲欠如とは、自発的な目的に沿った行動が減少すること
- 幻覚・妄想の重症度とは、独立して存在
- うつ病による気力低下や薬剤性錐体外路症状による感情表出の低下との鑑別を要する

解体症状 Disorganisation

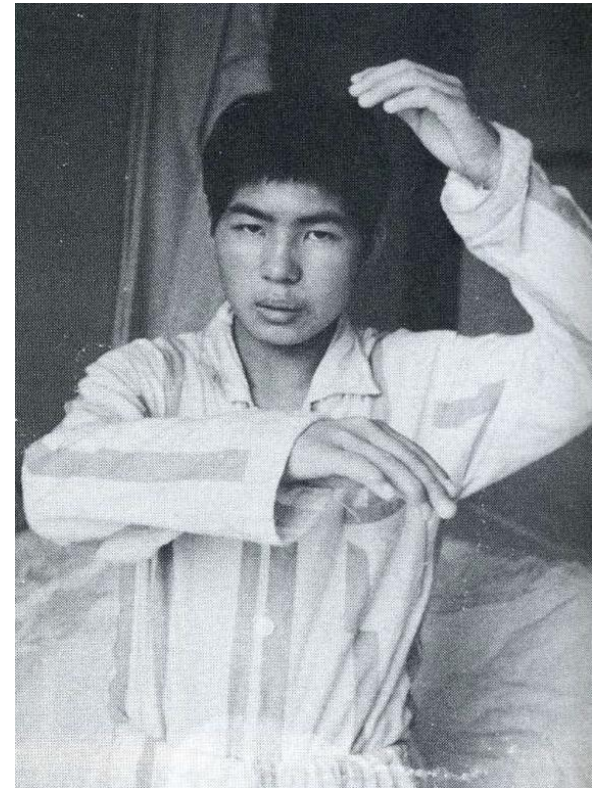
- 思考（発語）のまとまりがなくなること
 - 思考形式の障害
 - 幻覚・妄想の重症度とは、独立して存在
 - 接線性
 - 迂遠
 - 脱線
 - 言語新作
 - 言葉のサラダ
- 連合弛緩
(軽度)
- 支離滅裂
(重度)



出典：西丸四方 著「精神医学入門」

緊張病症状 Catatonia

- 身体疾患を含む他の障害下でも生じうる
- 定義は、12の特徴のうち1/4以上の存在
 - － 運動活動性の低下
 - カタレプシー/蠟屈症
 - 昏迷
 - － 関心の低下
 - 拒絶症
 - 無言症
 - － 運動活動性の過剰
 - 興奮
 - 常同症



出典：西丸四方 著「精神医学入門」

抑うつ・不安 Depression and Anxiety

- 統合失調症患者のうつ病の有病率はおおよそ25%と一般人口より高い
- 抑うつの危険因子は、知能や病識の高さ、最近の退院、家族の批判的な態度、スティグマ等
- 不安障害を併発する統合失調症スペクトラム障害患者はおおよそ38%
 - － 社交不安障害：14.9%
 - － 心的外傷後ストレス障害：12.4%
 - － 強迫性障害：12.1%
- 高い不安は、重度の陽性症状や抑うつと相関

薬物療法: 使用される治療薬の種類

抗不安薬

不安を軽減する

睡眠薬

睡眠を確保する

抗精神病薬

第一選択薬

気分安定薬

イライラ感を軽減する

その他

副作用止め、抗うつ薬 等

薬物療法: 抗精神病薬

- 陽性症状を改善するエビデンスが確立されている
- 定型抗精神病薬と非定型抗精神病薬に分類される
- 定型/非定型の効果の違い
 - － 陽性症状：定型と非定型の効果の有意な違いはない
 - － 陰性症状：定型の効果はなく、非定型の効果は小さい
- 定型/非定型の副作用の違い
 - － 定型と比べ、非定型は錐体外路症状が少ない傾向がある

薬剤間の効果差は小さいため、
副作用（と剤型）を考慮して最適な薬剤を選択

薬物療法: 定型抗精神病薬

□ ブチロフェノン系

- ー ハロペリドール
- ー ブロムペリドール

□ フェノチアジン系

- ー クロルプロマジン
- ー レボメプロマジン

□ その他

- ー ゾテピン
- ー スルピリド

薬物療法: 非定型抗精神病薬

- セロトニンドーパミン拮抗薬 (SDA)
 - ー リスペリドン
 - ー ペロスピロン
 - ー ブロナンセリン
 - ー パリペリドン
 - ー ルラシドン
- 多元受容体標的化抗精神病薬 (MARTA)
 - ー クロザピン
 - ー オランザピン
 - ー クエチアピン
 - ー アセナピン
- ドーパミン系安定化剤 (DSS)
 - ー アリピプラゾール
 - ー ブレクスピプラゾール

抗精神病薬の副作用: 錐体外路症状

- 抗精神病薬による二次性のパーキンソン症状
- 固縮・寡動・振戦
- 対処: 抗パーキンソン薬（抗コリン性/非抗コリン性）
- 抗コリン性薬剤は、口渇・便秘・尿閉・視力/認知機能障害に注意



抗精神病薬の副作用: 錐体外路症状



- アカシジアは、錐体外路症状（EPS）の副作用のうち、最多
- 体を動かしたくなる衝動を伴う運動性の落ち着きのなさ（静座不能）
- 軽症例では、感覚性
- 対処：抗精神病薬の減量/クロナゼパム/抗うつ薬/抗コリン薬/ β ブロッカー

抗精神病薬の副作用: 錐体外路症状



- 急性ジストニアは、主要筋群の不随意的収縮で生じ、若年男性に多い
- 斜頸・後弓反張・注視けいれん
- 喉頭けいれんは、稀ではあるが、致命的
- 対処: 抗コリン性作動薬の筋注/内服

抗精神病薬の副作用: 遅発性ジスキネジア



- 通常、年単位の抗精神病薬の使用で発症
- 口唇・舌・顔面・顎・四肢・体幹の不随意運動
- 危険因子は、急性期治療時のEPSや高齢
- 有効な治療法はない
(発症リスクの低い抗精神病薬への変薬は検討)

副作用: 代謝異常

- 心血管系イベントを始めとする若年死亡のリスクを高める
- 非定型 > 定型（アリピプラゾール、ハロペリドールは低リスク）
- オランザピンとクエチアピンは糖尿病禁忌



副作用: 高プロラクチン血症

- 定型抗精神病薬やリスペリドン、パリペリドンで上昇しやすい
- 月経不順・乳汁漏出、女性化乳房、性機能不全
- 対処: 抗精神病薬の変薬、アリピプラゾールの追加



抗精神病薬の副作用: 自律神経症状等

- 抗コリン作用、過飲水・水中毒
- 抗ヒスタミン作用、鎮静
- 起立性低血圧・頻脈、QT延長、突然死のリスク↑
- けいれん閾値↓



抗精神病薬の副作用: 悪性症候群

Gurreraらの診断基準

1. 発症72時間以内の
ドーパミン遮断薬の
投与や減薬・中止
2. 高熱: 38℃以上
3. 筋固縮
4. 意識障害
5. 自律神経症状
血圧上昇/変動、発汗、
尿失禁
6. 頻脈、頻呼吸
7. 鑑別診断の除外

- ドーパミン遮断薬の使用に関連する致死的な副作用
- 発熱・筋固縮・意識障害・自律神経異常を四徴とする
- 血液検査: 横紋筋融解によるクレアチニンキナーゼ (CK) 高値
- 対処: 原因薬剤中止・冷却・補液・ダントロレン静注

急性期治療: 抗精神病薬の剤型

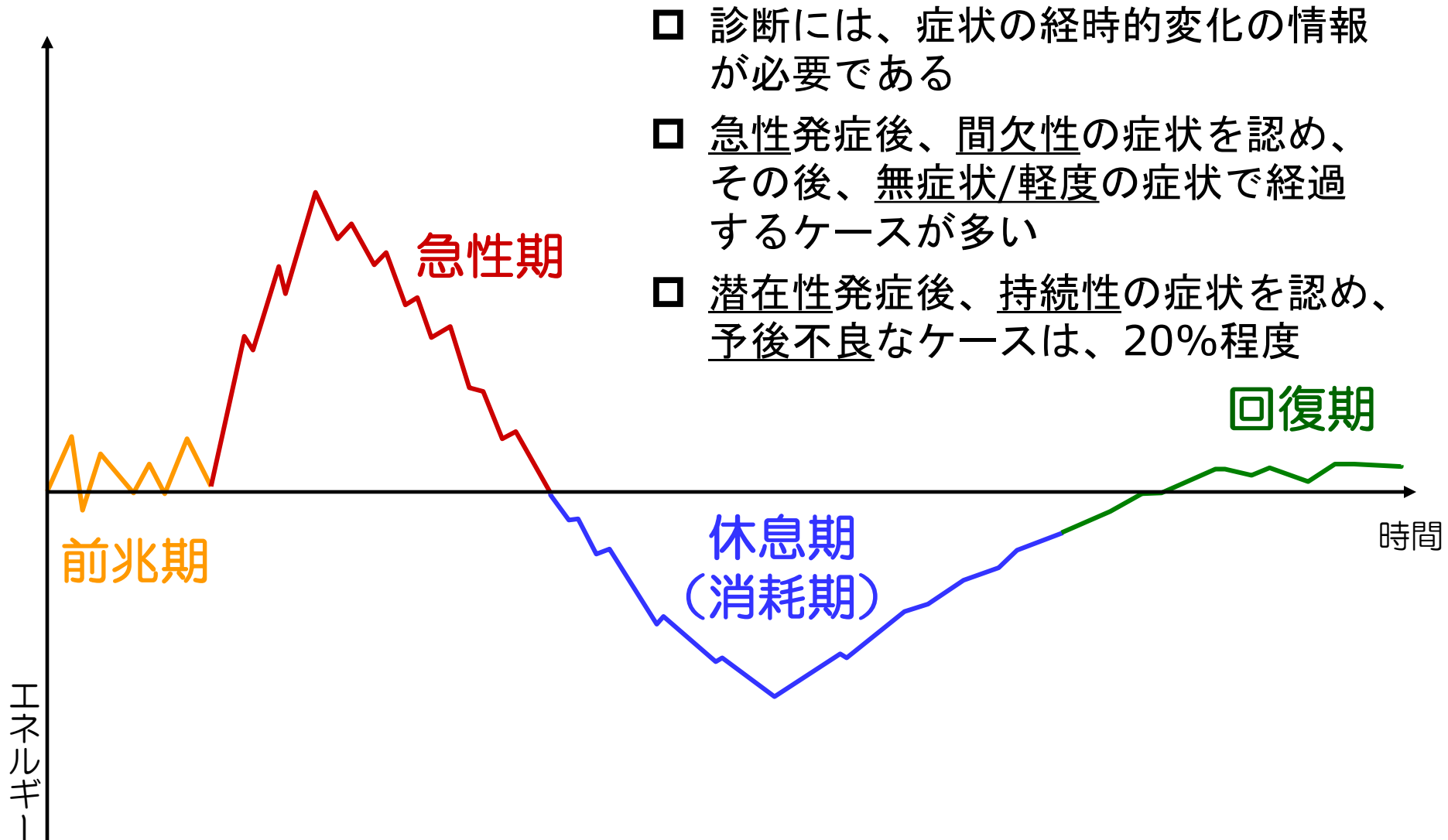


- 興奮が著しい場合、患者の緊急性と協力度で剤型を決定
- 鎮静効果は、投与後、30分程度で発現
- 錠剤と比べ、水薬と口腔内崩壊錠の効果発現時間は短い
- 経口投与が困難な場合、筋注と静注を選択
- 服薬遵守が困難な場合、デポ剤移行を視野

急性期治療: 抗精神病薬の使い方

- 効果判定には、投与量が治療域まで達してから、2週間（長くて4-6週間）かかる
- 治療効果を感じる前に、鎮静のような副作用が現れやすい
- 効果が乏しければ、副作用に注意しながら、治療域以上まで増加させる
- 2剤以上の抗精神病薬の併用療法を支持するエビデンスは少ない

統合失調症の経過



安定期治療: 抗精神病薬の使い方

- 統合失調症と診断された患者は、寛解しても生涯服薬を継続すべき
 - － 抗精神病薬を2年まで継続した場合、約3人に1人の再燃を予防できる
 - － 回復後、服薬不要な患者を予測することは難しい
- 副作用や社会機能の面から、病状安定後、減量をはかる方針が望ましい
 - － 初回エピソード後、用量を減量した群と維持した群を比較したRCTでは、前者の再発率が有意に高い

統合失調症の予後

Table 1. Cumulative Relapse Rates by Episode of Illness

Year*	Relapse Rate (95% Confidence Interval)	Patients Remaining at Risk at End of Year, No.
First Relapse—104 Patients at Risk		
1	16.2 (8.9-23.4)	80
2	53.7 (43.4-64.0)	39
3	63.1 (52.7-73.4)	22
4	74.7 (64.2-85.2)	9
5	81.9 (70.6-93.2)	4
Second Relapse—63 Patients at Risk		
1	19.1 (8.4-29.9)	36
2	48.7 (33.6-63.9)	17
3	56.0 (43.2-80.2)	10
4	56.0 (43.2-80.2)	3
5	78.0 (46.5-100.0)	1
Third Relapse—20 Patients at Risk		
1	12.5 (0-28.7)	10
2	31.1 (4.8-57.4)	7
3	72.4 (41.0-100.0)	2
4	86.2 (61.5-100.0)	1

* Refers to year(s) after recovery from the previous episode.

- 初発の統合失調症患者
104人の治療経過を
フォロー
- 薬物療法で初回エピソードが完解しても
 - 50%が2年以内、80%が5年以内に2回目エピソードを経験する
 - 3回目、4回目エピソードも5年以内に約80%が経験する

非薬物療法: 心理社会的介入

- 家族介入や精神療法の追加は、第一選択薬の抗精神病薬による薬物療法の効果を増強する
 - － 家族心理教育: 再発・再入院↓、服薬遵守↑
 - － 認知行動療法: 陽性症状↓、陰性症状↓
 - － 生活技能訓練: 生活スキル↑、陰性症状↓
- 包括型地域生活支援、雇用付き援助、早期介入等地域中心のサポートは、通常治療と比べ予後を改善する

エビデンスと普及の間のギャップ
を埋める必要がある

感情表出 (Expressed Emotion: EE)

EEの構成要素

批判的コメント	CC: Critical Comments
敵意	H: Hostility
情緒的巻き込まれ過ぎ	EOI: Emotional overinvolvement
暖かみ	W: Warmth
肯定的言辞	PR: Positive remarks

- 精神疾患患者とその家族の間に存在する対人関係の一側面
- 家族が患者に表出する感情の内容で測定
- 統合失調症では、High EE（一定レベル以上のCC・H・EOI）が再発の危険因子

